

PHOENIX evaluatiestudie

Fase 1 – onafhankelijke expertgeneratie

Instrument voor Zorgprofessionals

Deelnemerscode: HCP-PRE-03

Toegewezen casussen: **C05** (25-jarige postgraduaatsstudent) en **C06** (32-jarige marketingprofessional)

Studie	Evaluatie van de klinische kwaliteit van een ontologiegebaseerd multi-agentsysteem voor gepersonaliseerde digitale geestelijke gezondheidszorg (PHOENIX)
Instelling	Universiteit Gent – Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen
Onderzoeker	Stijn Van Severen (masterproefstudent)
Promotoren	Prof. Dr. Geert Crombez; Dr. Annick De Paepe
Contact	stijn.vanseveren@ugent.be
Geschatte duur	Ongeveer 35–45 minuten voor beide casussen samen

Doel van deze bundel

U neemt deel aan een evaluatiestudie waarin zorgprofessionals onafhankelijk dezelfde vijf klinische redeneerstappen uitvoeren als het PHOENIX-systeem. Uw antwoorden vormen het menselijke referentiecorpus voor een latere dubbelblinde vergelijking met systeemoutput.

Voor elk van uw twee casussen vult u dezelfde vijf delen in: (1) operationalisering, (2) initieel observatiemodel, (3) prioritering van behandeldoelen, (4) verfijning van EMA-metingen en (5) een mobiele coachingsboodschap.

We vragen uw eigen klinische oordeelsvorming. Antwoord zoals u dat in een reële professionele context zou doen, maar werk strikt volgens de instructies op de volgende pagina.

Vertrouwelijkheid: uw antwoorden worden voor analyse geanonimiseerd en uitsluitend gebruikt binnen deze masterproefstudie. Deelname is vrijwillig; u kan zich op elk moment terugtrekken door contact op te nemen met de onderzoeker.

Contents

1	Instructiepagina	3
2	Deel 1: Operationalisering van de mentale gezondheidstoestand	5
3	Deel 2: Initieel observatiemodel (bipartiet netwerk)	8
4	Deel 3: Behandeldoelprioritering via het bipartiet netwerk	11
5	Deel 4: Verfijnd observatiemodel – selectie van sub-predictoren	14
6	Deel 5: Gepersonaliseerde mobiele coachingsboodschap (HAPA-kader)	17
7	Afronding en terugbezorging	20

1 Instructiepagina

Het PHOENIX-systeem en de context van deze studie

PHOENIX (Personalized Hierarchical Optimization Engine for Navigating Insightful eXplorations) is een multi-agentsysteem ontwikkeld als onderdeel van een masterproef in de psychologie aan de Universiteit Gent. Het systeem verwerkt een vrije klachttekst en doorloopt vijf opeenvolgende klinische redeneerstappen die de kern vormen van een gepersonaliseerde, longitudinale digitale interventie.

Het theoretische kader van PHOENIX steunt op het **netwerk-analytisch model van psychopathologie** (Borsboom & Cramer, 2013): psychische klachten worden niet als uitingen van een latente stoornis beschouwd, maar als een *dynamisch netwerk van onderling samenhangende klachtcomponenten*. Een sleutelbegrip daarbinnen is het onderscheid tussen **criteria** (symptoomdimensies die de toestand van de persoon beschrijven) en **predictoren** (modificeerbare variabelen die de criteria causaal beïnvloeden en als behandeldoel kunnen dienen).

Kerndefinities: criterium versus predictor

Criterium (CR): een klinisch relevante, momentaan aanwezige *klacht- of toestandsdimensie* van de persoon die herhaald meetbaar is via dagelijkse EMA. Criteria zijn de *uitkomstvariabelen* in het netwerk – ze beschrijven *wat er mis gaat* (bijv. inslaapproblemen, paniekepisoden, sombere stemming). Criteria zijn geen gedragingen of interventies.

Predictor (P): een *modificeerbare gedrags- of procesvariabele* die plausibel causaal ingrijpt op een of meerdere criteria en dagelijks meetbaar is via een korte EMA-vraag. Predictoren zijn de *ingreepvariabelen* in het netwerk – ze beschrijven *wat veranderbaar is* (bijv. avondschermtijd, geplande exposure, aerobe beweging). Een predictor is *nooit een symptoom zelf*, maar een gedrag, strategie of omgevingsfactor die het symptoom beïnvloedt.

Voorbeelden ter verduidelijking:

- **Criterium:** inslaapproblemen, anticipatieangst, anergie, guilt-driven ruminatie.
- **Predictor:** avondschermtijd (min), geplande exposurestap (ja/nee), bewegingsfrequentie (min), preslaap-offloading (ja/nee).
- **Geen predictor, geen criterium:** eetlust bij avondmaal, rusthartslag, spierspanning – dit zijn symptoom- of toestandsmaten, geen behandelbare predictoren.

Ecological Momentary Assessment (EMA) – basisprincipes

EMA is een methode waarbij personen meerdere keren per dag hun actuele toestand of gedrag rapporteren via een mobiele applicatie. In PHOENIX wordt EMA gebruikt om zowel criteria als predictoren dagelijks te monitoren over een periode van meerdere weken.

Een goede EMA-variabele voldoet aan vier vereisten:

- **Dagelijks rapporteerbaar:** via een korte vraag op de smartphone (ja/nee, aantal, minuten of 0–10).
- **Dynamisch en veranderbaar:** geen vaste trek, diagnose of stabiel achtergrondkenmerk.
- **Klinisch relevant:** toont binnen-persoonsvariatie die therapeutisch informatief is.
- **Onderscheid criterium vs. predictor:** symptoomdimensies zijn criteria; modificeerbare gedragingen zijn predictoren.

Het bipartiet netwerk: structuur van het observatiemodel

Na 21 dagen EMA-monitoring construeert PHOENIX een **bipartiet netwerk**: een graaf met twee kolommen sets en gewogen verbindingen daartussen.

- **Linkse kolom – Predictoren (P)**: de modificeerbare variabelen.
- **Rechtse kolom – Criteria (CR)**: de klacht- en toestandsdimensies.
- **Kanten**: de richting loopt van predictor naar criterium ($P \rightarrow CR$). Een *blauwe* rand duidt op een positief verband (predictor vergroot het criterium), een *rode* rand op een negatief verband (predictor verkleint het criterium). Lijndikte is proportioneel aan de sterkte van het empirische verband uit de monitoringdata.

In **Deel 3** rangschikt u de predictoren op behandelprioriteit op basis van dit netwerk en de monitoringsamenvatting.

Overzicht van de vijf taken

Stap	Klinische taak	Wat u doet	Richttijd
1	Operationalisering	Identificeer 2–6 criteriumlabels (klacht-dimensies)	≈ 6 min
2	Initieel observatiemodel	Genereer 3–5 predictorlabels (modificeerbaar, EMA-geslacht)	≈ 6 min
3	Behandeldoelprioritering	Rangschik alle 5 predictoren van hoog naar laag behandelprioriteit	≈ 7 min
4	Verfijnd observatiemodel	Selecteer exact 6 EMA-items (2 per behandeldoel) uit de lijst van 20	≈ 8 min
5	Mobiele coaching	Schrijf een korte patientgerichte boodschap voor de app	≈ 8 min
Totaal (2 casussen)			35–45 min

Werkwijze – strikt te volgen

1. **Werk sequentieel: Deel 1 → Deel 5.** Ga pas naar een volgend deel wanneer het huidige deel volledig is afgewerkt voor beide casussen.
2. **Gebruik geen generatieve AI, schrijfhulpmiddelen, richtlijnen of collegaoverleg.** Extern gebruik ondermijnt de methodologische validiteit en de blind scoringswaarde van de studie.
3. **Gebruik in latere delen uitsluitend de meegeleverde gestandaardiseerde context.** Die is bewust vastgezet zodat alle deelnemers op identieke input reageren en vergelijkbaar zijn.
4. **Herwerk eerdere antwoorden niet retroactief** nadat u latere context hebt gezien.
5. **Noteer of typ rechtstreeks in de voorziene antwoordzones.** Onleesbare of ambigu geformuleerde antwoorden bemoeilijken latere blinde beoordeling.

2 Deel 1: Operationalisering van de mentale gezondheidstoestand

Instructies Deel 1

Opdracht: identificeer de belangrijkste actuele klacht- en toestandsdimensies (**criteria**) in de klachttekst en noteer voor elke dimensie uitsluitend een **kort criteriumlabel**.

Wat is een criterium? Een criterium is een *symptoom- of klachtdimensie* die beschrijft *wat er mis gaat* bij de persoon. Het is *geen* behandeling, geen gedrag en geen oorzaak, maar een actuele toestandsbeschrijving:

- momenteel aanwezig bij de persoon (niet hypothetisch of anamnestic),
- onderscheidbaar van andere klachtdimensies (niet overlappend),
- in principe herhaald meetbaar via dagelijkse zelfrapportage (EMA).

Voorbeelden van goede criteriumlabels: inslaapproblemen, paniekepisoden, anticipatieangst, sombere stemming, emotionele uitputting, anergie, interpersoonlijke instabiliteit, compulsief controlegedrag.

Let op: gedragingen (bijv. “avondschermtijd”), oorzaken (bijv. “werkstress”) en behandelstrategieën zijn *geen* criteria maar predictoren – die horen in Deel 2.

Antwoordformat: label van 2–5 woorden, zonder beschrijvende zin. Noteer per casus **2–6 criteria**. Laat ongebruikte velden leeg.

Casus 1: 25-jarige postgraduaatsstudent

“Ik krijg gedachten dat ik per ongeluk iemand zou kunnen verwonden, ook al wil ik dat helemaal niet en weet ik dat die gedachten irrationeel zijn. Ze komen plots op en voelen dan heel echt en beangstigend aan. Daarna ben ik uren bezig met in mijn hoofd na te gaan of ik niets fout heb gedaan. Ik ben ook situaties beginnen vermijden waarin ik iets scherp zou kunnen vasthouden, wat mijn dagelijks leven en sociale contacten beïnvloedt. Dat mentale controleren neemt uren in beslag en begint mijn studies en relaties serieus te verstoren.”

Opdracht: noteer **2–6 criteriumlabels** voor deze casus. Gebruik enkel korte labels; voeg geen beschrijving toe.

Criterium 1 Label (2–5 woorden): _____

Criterium 2 Label (2–5 woorden): _____

Criterium 3 Label (2–5 woorden): _____

Criterium 4 Label (2–5 woorden): _____

Criterium 5 Label (2–5 woorden): _____

Criterium 6 Label (2–5 woorden): _____

Casus 2: 32-jarige marketingprofessional

“Ik ervaar heel veel angst in professionele situaties. Wanneer ik moet presenteren, in een vergadering iets moet zeggen of feedback krijg van mijn leidinggevende, word ik zo zelfbewust dat mijn hoofd leegloopt. Vooraf spendeer ik uren aan voorbereiden, maar in het moment zelf blokkeer ik toch. Achteraf blijf ik lang analyseren wat ik precies heb gezegd en hoe ik overkwam. Ik heb al meerdere promoties en interessante projecten afgeslagen omdat ik bang was voor de extra zichtbaarheid. Ik besef dat mijn angst voor de beoordeling door anderen buiten proportie is, maar ik krijg ze niet stil.”

Opdracht: noteer **2–6 criteriumlabels** voor deze casus. Gebruik enkel korte labels; voeg geen beschrijving toe.

Criterion 1 Label (2–5 woorden): _____

Criterion 2 Label (2–5 woorden): _____

Criterion 3 Label (2–5 woorden): _____

Criterion 4 Label (2–5 woorden): _____

Criterion 5 Label (2–5 woorden): _____

Criterion 6 Label (2–5 woorden): _____

3 Deel 2: Initieel observatiemodel (bipartiet netwerk)

Instructies Deel 2

Opdracht: genereer **3–5 predictorlabels** die samen het **initieel observatiemodel** voor deze casus vormen.

Wat is een predictor in deze context? Een predictor is een *modificeerbare gedrags- of procesvariabele* die beschrijft *wat de persoon kan veranderen*:

- **Modificeerbaar:** de persoon (of therapeut) kan er rechtstreeks op ingrijpen.
- **EMA-geschikt:** dagelijks meetbaar via een eenvoudige vraag op de smartphone (ja/nee, aantal, minuten of 0–10 schaal).
- **Causaal plausibel:** klinisch aannemelijk dat het predictor de criteria beïnvloedt.
- **Geen criterium:** symptomen, klachtniveaus of diagnostische trekken zijn *geen* predictoren.

Voorbeelden van goede predictorlabels: avondschermtijd, geplande exposure, aerobe beweging, preslaap-offloading, veiligheidsgedrag, werk-privegrens, herstelactiviteit, compulsie-uitstel.

Let op: predictoren als “eetlust”, “spierspanning” of “moeheid” zijn symptoomdimensies (criteria) – geen predictoren. Kies variabelen die de persoon actief kan uitvoeren of aanpassen.

Antwoordformat: enkel een label van 2–6 woorden, zonder meetdefinitie of toelichting. Laat ongebruikte velden leeg.

Casus 1: 25-jarige postgraduaatsstudent – Deel 2

25-jarige postgraduaatsstudent; duur: ongeveer 20 maanden. Intrusieve schadeobsessies, compulsieve mentale controle, vermijding van schaderisico en uitgesproken tijdsbelasting door OCD-klachten.

Gestandaardiseerde criteria uit stap 1:

- **CR-1** Intrusieve schadeobsessies
- **CR-2** Compulsieve mentale controle
- **CR-3** Vermijding van schaderisico
- **CR-4** Tijdsbelasting door OCD

Opdracht: noteer **3–5 predictorlabels** voor een initieel observatiemodel. Zorg dat elk label later dagelijks via een mobiele app meetbaar kan worden gemaakt.

Predictor 1 Label (2–6 woorden): _____

Predictor 2 Label (2–6 woorden): _____

Predictor 3 Label (2–6 woorden): _____

Predictor 4 Label (2–6 woorden): _____

Predictor 5 Label (2–6 woorden): _____

Casus 2: 32-jarige marketingprofessional – Deel 2

32-jarige marketingprofessional; duur: persisterend sinds het begin van de loopbaan (meer dan 3 jaar). Prestatieangst op het werk, post-event ruminatie, excessieve voorbereiding en vermijding van zichtbaarheid.

Gestandaardiseerde criteria uit stap 1:

- **CR-1** Prestatieangst op het werk
- **CR-2** Post-event ruminatie
- **CR-3** Excessieve voorbereiding
- **CR-4** Vermijding van zichtbaarheid

Opdracht: noteer **3–5 predictorlabels** voor een initieel observatiemodel. Zorg dat elk label later dagelijks via een mobiele app meetbaar kan worden gemaakt.

Predictor 1 Label (2–6 woorden): _____

Predictor 2 Label (2–6 woorden): _____

Predictor 3 Label (2–6 woorden): _____

Predictor 4 Label (2–6 woorden): _____

Predictor 5 Label (2–6 woorden): _____

4 Deel 3: Behandeldoelprioritering via het bipartiet netwerk

Instructies Deel 3

Opdracht: rangschik de **5 standaardpredictoren** van **hoogste** naar **laagste** behandelprioriteit.

Wat is een behandeldoel? Een behandeldoel is de predictor die, als hij veranderd wordt, naar verwachting de sterkste vermindering van de criteria oplevert. U selecteert op basis van drie criteria:

- a) **Bewijs uit monitoring:** is er in de monitoringdata aanleiding dat deze predictor actief bijdraagt aan de klacht (bijv. hoge frequentie van problematisch gedrag, of bijna afwezigheid van gewenst gedrag)?
- b) **Klinische modificeerbaarheid:** is de predictor realistisch veranderbaar voor deze persoon, gegeven profiel en context?
- c) **Netwerkimpact:** beïnvloedt de predictor meerdere criteria tegelijk (hogere return-on-intervention)?

Het bipartiet netwerk lezen:

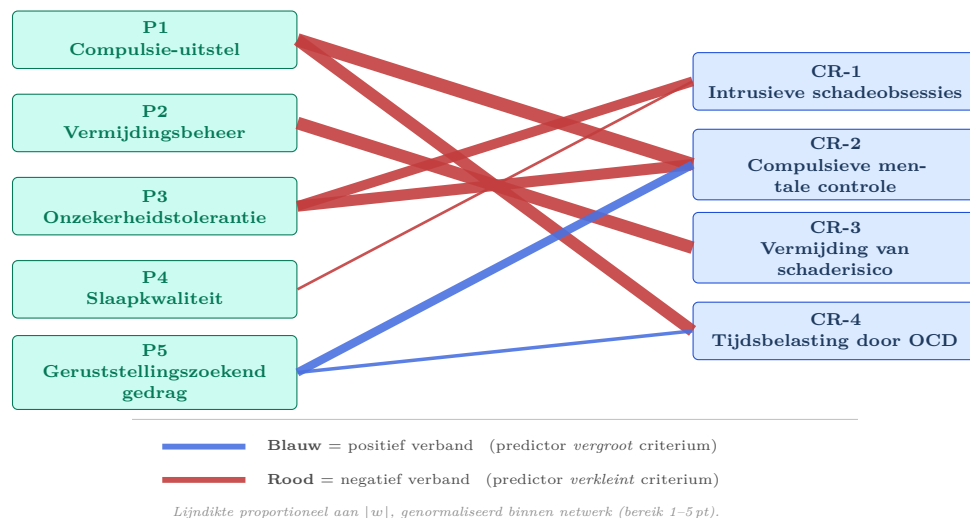
- Predictoren staan in de **linkerkolom (groen)**; criteria in de **rechterkolom (blauw)**.
- **Blauwe rand:** predictor heeft een positief verband met het criterium (hogere predictor → hoger criterium; bijv. meer veiligheidsgedrag → meer angst).
- **Rode rand:** predictor heeft een negatief verband met het criterium (hogere predictor → lager criterium; bijv. meer exposure → minder vermijding).
- **Lijndikte:** proportioneel aan de sterkte van het empirische verband (21-daagse EMA-data).

Antwoordformat: vul alle 5 prioriteitslijnen in, van rangorde 1 (hoogste prioriteit) tot en met 5 (laagste prioriteit).

Casus 1: 25-jarige postgraduaatsstudent – Deel 3

Intrusieve schadeobsessies, compulsieve mentale controle, vermijding van schaderisico en uitgesproken tijdsbelasting door OCD-klachten. Duur: ongeveer 20 maanden.

21-daagse monitoring: Compulsie- en controletijd: gem. 2,4 uur/dag. Vermijdingsepisodes: gem. 3,8/dag. Weerstandsoefening: gem. 18 min/dag. Distress bij niet reageren: 7,2/10. Slaap: gem. 5,6 uur/nacht. Geruststellingsvragen: gem. 4,1/dag.



Opdracht: rangschik alle 5 predictors van hoogste naar laagste behandelprioriteit. **Beschikbare predictors:** P1: Compulsie-uitstel, P2: Vermijdingsbeheer, P3: Onzekerheidstolerantie, P4: Slaapkwaliteit, P5: Geruststellingszoekend gedrag

Prioriteit 1

Prioriteit 2

Prioriteit 3

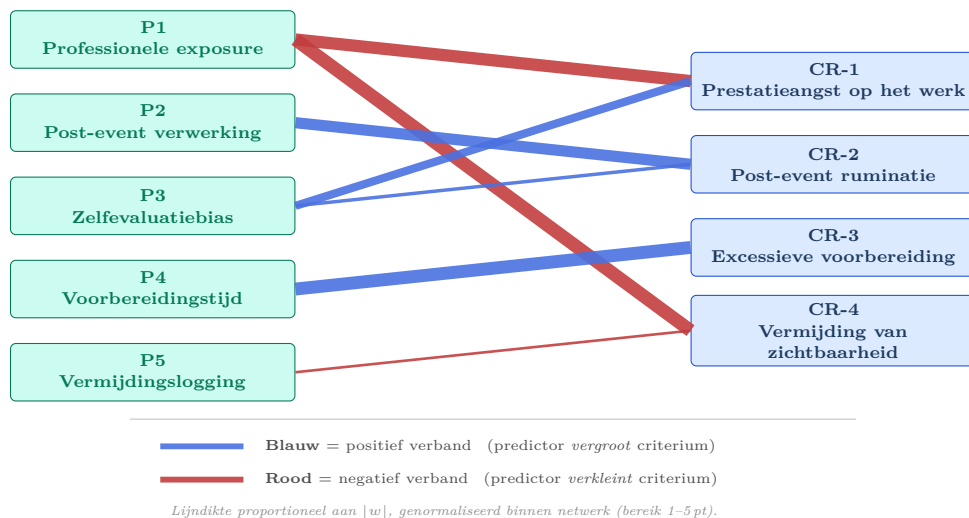
Prioriteit 4

Prioriteit 5

Casus 2: 32-jarige marketingprofessional – Deel 3

Prestatieangst op het werk, post-event ruminatie, excessieve voorbereiding en vermijding van zichtbaarheid. Duur: persisterend sinds het begin van de loopbaan (meer dan 3 jaar).

21-daagse monitoring: Professionele exposures aangegaan: gem. 0,9/week. Post-event verwerkingstijd: gem. 68 min per gebeurtenis. Pre-event voorbereiding: gem. 3,2 uur per gebeurtenis. Zelfbeoordeling versus externe feedback: 4,1 versus 6,8/10. Afgeslagen doorgroeikansen: 3 in de voorbije 4 weken.



Opdracht: rangschik alle 5 predictors van hoogste naar laagste behandelprioriteit. **Beschikbare predictors:** P1: Professionele exposure, P2: Post-event verwerking, P3: Zelfevaluatiebias, P4: Voorbereidingstijd, P5: Vermijdingslogging

Prioriteit 1	_____
Prioriteit 2	_____
Prioriteit 3	_____
Prioriteit 4	_____
Prioriteit 5	_____

5 Deel 4: Verfijnd observatiemodel – selectie van sub-predictoren

Instructies Deel 4

Opdracht: selecteer per casus **exact 6 EMA-items: 2 sub-predictoren per behandeldoel** (3 behandeldoelen $\times$ 2 = 6 items).

Wat zijn sub-predictoren? Een behandeldoel uit Deel 3 (bijv. “geplande exposure”) is een conceptueel label. In de volgende EMA-cyclus moet dit label vertaald worden naar *concrete, dagelijks meetbare gedragsitems* – de **sub-predictoren**. Elke sub-predictor is een specifieke operationalisering van het behandeldoel als dagelijkse EMA-vraag.

Voorbeeld: behandeldoel = *avondschermtijd* → sub-predictor 1: “smartphone-gebruik na 22.00 uur (min)” → sub-predictor 2: “schermvrij interval voor slapengaan (min)”

Belangrijk: alle 20 items in de lijst zijn **predictor-type EMA-items** (modificeerbare gedragingen en strategieën – *geen* symptomen of klachtdimensies). Uw taak is te selecteren welke 6 items het best aansluiten bij de 3 gestandaardiseerde behandeldoelen, 2 per doel.

Selectieprincipe:

- Kies per behandeldoel de 2 items die dat doel het meest direct en precies meten.
- Verkies items die samen een compleet beeld geven van het behandeldoel (bijv. frequentie *en* duur, of twee complementaire gedragingen).
- Vermijd items die het behandeldoel slechts zijdelings raken.

Antwoordformat: vink **exact 6** items aan. Geen toelichting vereist.

Casus 1: 25-jarige postgraduaatsstudent – Deel 4

Gestandaardiseerde behandeldoelen uit Deel 3:

1. **Compulsie-uitstel** (*weinig toegepast ten opzichte van de benodigde ERP-intensiteit; centraal aangrijpingspunt*)
2. **Vermijdingsbeheer** (*hoge vermijdingsfrequentie onderhoudt de obsessie-compulsiecyclus*)
3. **Onzekerheidstolerantie** (*lage tolerantie voedt zowel intrusies als mentale controle*)

Opdracht: selecteer **exact 6** EMA-items (2 per behandeldoel) die het best passen als volgende subpredictoren. *Alle antwoordopties zijn dagelijkse mobiele EMA-items.*

1. ☐ Schermtijd na 22.00 uur bewust beperkt (min)
2. ☐ Minuten gewacht voor uitvoeren van een compulsieve handeling (min)
3. ☐ Slaaptijdstip consistent aangehouden (ja/nee)
4. ☐ Compulsieve handeling volledig uitgesteld tot later of niet uitgevoerd (ja/nee)
5. ☐ Ontspanningsoefening of grondingsoefening bewust uitgevoerd (min)
6. ☐ Cafeïne-inname na de middag (aantal)
7. ☐ Vermeden situatie bewust betreden zonder uitvoering van compulsie (ja/nee)
8. ☐ Sociale activiteit bijgewoond of sociaal contact bewust gezocht (ja/nee)
9. ☐ Bewuste activiteit gekozen als alternatief voor obsessief piekeren (min)
10. ☐ Duur verblijf in obsessie-activerende situatie zonder vermijden (min)
11. ☐ Geruststellingsvraag bewust nagelaten (aantal)
12. ☐ Slaapritme consistent gevolgd (ja/nee)
13. ☐ Onzekerheid bewust getolereerd zonder controle- of compulsieve handeling (min)
14. ☐ Maaltijdmoment op vaste tijd aangehouden (ja/nee)
15. ☐ Alcoholinname vanavond (eenheden)
16. ☐ Onzekerheidstolerantieoefening bewust en gepland uitgevoerd (ja/nee)
17. ☐ Gefocuste studieoefening of pomodoro-blok bijgehouden (aantal)
18. ☐ Contact met vrienden of bekenden vandaag bewust gezocht (ja/nee)
19. ☐ Waterinname vandaag (glazen)
20. ☐ Lichaamsbeweging of sport vandaag (min)

Totaal geselecteerd: _____ / 6

Casus 2: 32-jarige marketingprofessional – Deel 4

Gestandaardiseerde behandeldoelen uit Deel 3:

1. **Professionele exposure** (*lage frequentie terwijl dit het kernmechanisme is voor angstreductie*)
2. **Post-event verwerking** (*gemiddeld 68 minuten per gebeurtenis; duidelijke onderhoudende factor voor CR-2*)
3. **Vermijdingslogging** (*zichtbaar maken van gemiste kansen is cruciaal voor CR-4 en behandelsturing*)

Opdracht: selecteer **exact 6** EMA-items (2 per behandeldoel) die het best passen als volgende subpredictoren. *Alle antwoordopties zijn dagelijkse mobiele EMA-items.*

1. ☐ Consistent slaap- en waktijdstip aangehouden (ja/nee)
2. ☐ Professionele situatie bewust opgezocht of niet vermeden (ja/nee)
3. ☐ Cafeïne-inname voor een professionele afspraak bewust beperkt (ja/nee)
4. ☐ Ontspanningsoefening voor een stressvolle werksituatie bewust uitgevoerd (min)
5. ☐ Spreektijd of actieve bijdrage in vergadering bewust geleverd (min)
6. ☐ Positieve professionele ervaring bewust genoteerd (ja/nee)
7. ☐ Tijd besteed aan naverwerking van professionele prestatie in avond (min)
8. ☐ Werkuren op kantoor of thuis vandaag (uren)
9. ☐ Middagpauze bewust en schermvrij genomen (ja/nee)
10. ☐ Mentale replay van professionele situatie voor slapengaan bewust gestopt (ja/nee)
11. ☐ Schermtijd na 21.00 uur (min)
12. ☐ Zelfevaluatie vergeleken met ontvangen externe feedback (ja/nee)
13. ☐ Gemiste professionele kans of bewust uitwijking genoteerd (ja/nee)
14. ☐ Lunchpauze bewust genomen weg van het scherm (ja/nee)
15. ☐ Aerobe beweging of sport vandaag uitgevoerd (min)
16. ☐ Vermijdingsepisode (bewust afgeslagen kans) in logboek bijgehouden (ja/nee)
17. ☐ Assertieve of constructieve reactie bewust gekozen in werkconflict (ja/nee)
18. ☐ Ochtendactiviteit voor werk uitgevoerd als dagstarter (min)
19. ☐ Aantal sociale berichten verstuurd of reactie gegeven (aantal)
20. ☐ Sociale steun of begeleiding bewust gevraagd (ja/nee)

Totaal geselecteerd: _____ / 6

6 Deel 5: Gepersonaliseerde mobiele coachingsboodschap (HAPA-kader)

Instructies Deel 5

Opdracht: schrijf een korte, rechtstreeks tot de persoon gerichte coachingsboodschap die in de mobiele applicatie verschijnt.

Theoretisch kader – HAPA: PHOENIX gebruikt het **Health Action Process Approach (HAPA; Schwarzer, 1992)** om de boodschap af te stemmen op de motivationele fase van de persoon:

- **Pre-intentionele fase:** de persoon is nog niet gemotiveerd om te veranderen → focus op risicobewustzijn en uitkomstverwachting.
- **Intentionele fase:** de persoon wil veranderen maar heeft nog geen concreet plan → focus op doelstelling en actieplanning.
- **Actie-/onderhoudsfase:** de persoon probeert al te veranderen → focus op copingplanning en zelfeffectiviteitsondersteuning.

U hoeft de fase niet expliciet te benoemen; gebruik het kader om de toon en inhoud van uw boodschap te sturen.

De boodschap voldoet aan:

- **Lengte:** 2–4 zinnen, compact genoeg voor een mobiel scherm.
- **Toon:** warm, direct, professioneel – geen klinisch jargon of diagnostische labels.
- **Inhoud:** adresseert het primaire behandeldoel en de voornaamste barriere; bevat een concrete, eerstvolgende actie.
- **Perspectief:** tweede persoon (“jij” of formeel “u”).

Werkvoorbeeld (niet gerelateerd aan een studiecaser):

Context: verpleegkundige; behandeldoel = korte beweegmomenten inbouwen; barriere = vermoeidheid na de shift (lage zelfeffectiviteit); fase = intentioneel.

Voorbeeldboodschap:

“Na een zware shift voelt rust nemen logisch, maar net dat eerste kleine beweegmoment kan je avond helpen ontladen. Trek vanavond meteen na thuiskomst je schoenen aan en wandel 10 minuten buiten – niet meer dan dat ene blokje. Zo maak je de stap haalbaar en vergroot je de kans dat je lichaam later echt kan afschakelen.”

Casus 1: 25-jarige postgraduaatsstudent – Deel 5

Primair probleem

Belastende intrusieve gedachten leiden tot langdurige mentale controle en duidelijke functionele hinder.

Behandeldoel

De tijd tussen intrusie en controlehandeling systematisch verlengen.

Voornaamste barriere

Overschat risico: niet controleren voelt moreel onverantwoord en potentieel gevaarlijk.

Copingstrategie

Gebruik een uitstelregel met een korte grondingsoefening als vast alternatief tijdens de eerste minuten.

Opdracht: schrijf hieronder de mobiele coachingsboodschap voor deze casus. *Formuleer alsof de tekst morgen rechtstreeks op de smartphone van de persoon verschijnt.*

Casus 2: 32-jarige marketingprofessional – Deel 5**Primair probleem**

Sterke angst in professionele evaluatie- en zichtbaarheidssituaties met langdurige naverwerking.

Behandeldoel

Professionele exposure uitvoeren ondanks spanning en achteraf functioneel evalueren.

Voornaamste barriere

Grote kloof in zelfeffectiviteit: de persoon verwacht dat exposure zal bevestigen dat hij of zij tekortschiet.

Copingstrategie

Gebruik een gedragsproef waarbij voorspelde prestatie expliciet wordt vergeleken met feitelijke feedback.

Opdracht: schrijf hieronder de mobiele coachingsboodschap voor deze casus. *Formuleer alsof de tekst morgen rechtstreeks op de smartphone van de persoon verschijnt.*

7 Afronding en terugbezorging

Dank u voor het invullen van alle vijf delen voor uw twee toegewezen casussen (Casus 1 en Casus 2).

Checklist voor terugbezorging

- ☐ Ik heb in Deel 1 voor beide casussen criteriumlabels ingevuld.
- ☐ Ik heb in Deel 2 voor beide casussen predictorlabels ingevuld.
- ☐ Ik heb in Deel 3 voor beide casussen alle 5 predictors gerangschikt.
- ☐ Ik heb in Deel 4 voor beide casussen exact 6 EMA-items geselecteerd.
- ☐ Ik heb in Deel 5 voor beide casussen een mobiele coachingsboodschap geschreven.
- ☐ Mijn antwoorden weerspiegelen mijn eigen klinische oordeel zonder gebruik van generatieve AI of andere externe hulp.
- ☐ Ik begrijp dat mijn antwoorden geanonimiseerd worden voor analyse.

Bezorg het ingevulde document terug via e-mail aan:

`stijn.vanseveren@ugent.be` met onderwerp: PHOENIX-PRE-HCP-PRE-03

Na ontvangst worden uw antwoorden geanonimiseerd en opgenomen in het expertreferentiecorpus voor de latere blind evaluatie van PHOENIX. Hartelijk dank voor uw bijdrage aan dit onderzoek.